

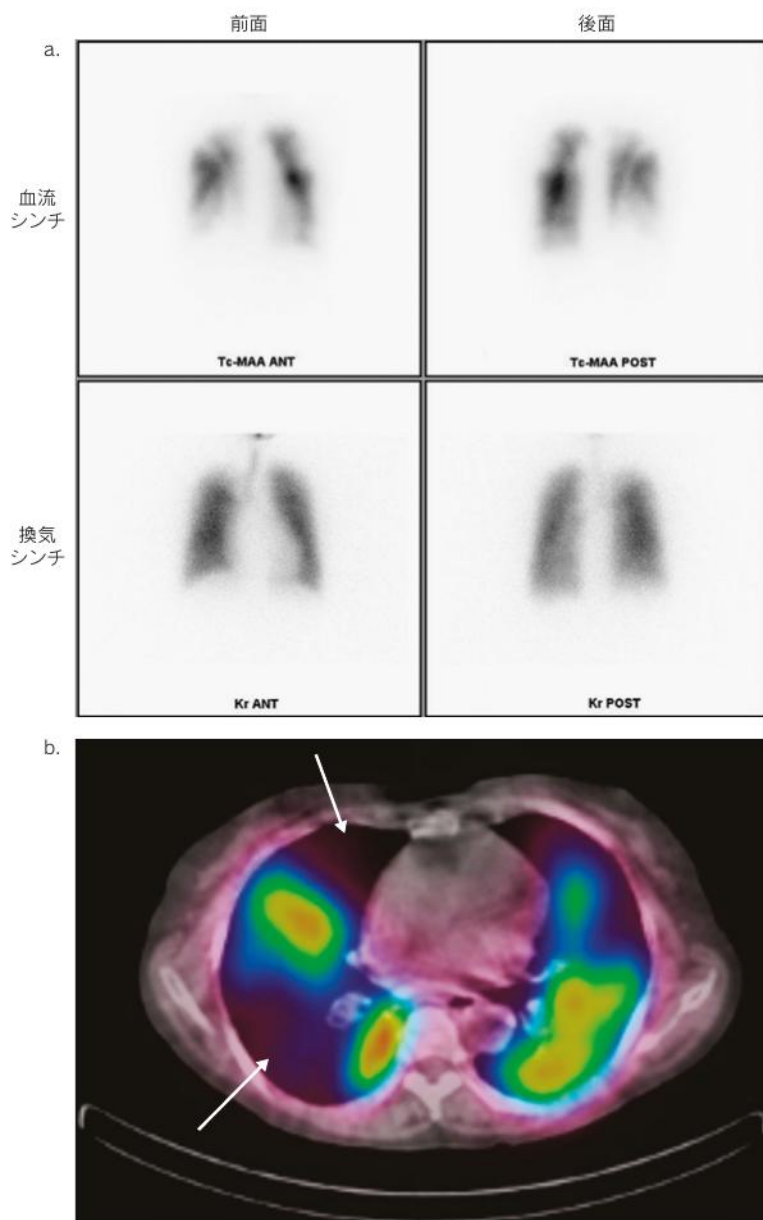


図1 肺血栓塞栓症の肺換気・血流シンチグラフィ (a) と SPECT (b) (同一症例)

a: 換気に異常を認めず (下段), 血流に多発性区域性欠損を認める (上段).

b: 血流欠損部位 (矢印) が明瞭である.

り、肺動脈が収縮し血流が低下するため、血流シンチグラフィでも集積が低下する。そのため肺気腫や無気肺などの肺実質の異常でも集積低下を認める。肺動脈の支配領域に相当する区域性・亜区域性の血流が欠損し、かつ換気が保たれている部位を換気・血流ミスマッチとして肺塞栓領域を検出する。

a 急性・慢性肺血栓塞栓症

近年は肺動脈内の血栓そのものが評価できる造影CTが急性肺血栓塞栓症診断の第一選択となっている。しかし肺血流シンチグラフィはスクリーニング検

査法として依然として有用であり、特に正常であれば肺血栓塞栓症は否定的である。

肺門側を頂点とした多発性楔状欠損像を呈する典型的なシンチグラフィ所見を示す場合、肺血栓塞栓症の診断は容易だが、その判定が困難な場合も少なくない。PIOPED 診断基準は1990年に報告されたが、2008年に再検討による修正が加えられた (PIOPED II) (表1)¹⁾。シンチグラフィのみで肺血栓塞栓症の有無が確定できる症例も多く、2つ以上の区域性換気・血流ミスマッチを認める高可能性を示した場合に